

NOTULEN

HARI / TANGGAL : RABU / 22 APRIL 2026
 PUKUL : 09.00 – 09.55 WIB
 AGENDA RAPAT : RAPAT TRIBULAN

PEMIMPIN RAPAT : dr. RESTI LESTANTINI, M. Kes
 NOTULIS : MAHESA YUDISTIRANTI, S.AP
 TEMPAT : LOKASI DINAS MASING – MASING
 (ZOOM MEETING)

Berikut hasil notulen :

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Rapat Tribulan	1. Evaluasi rapat koordinasi	Evaluasi rapat koordinasi dilakukan kepala Unit selama 3 bulan	Karu
		2. PPI, PKRS, PPRA, MFK evaluasi program	Lakukan evaluasi program koordinasi 4 komite / tim tersebut	1. PPI 2. PKRS 3. PPRA 4. MFK
		3. Capaian INM harus dilakukan evaluasi	1. Angka kepatuhan penggunaan APD masih kurang : 1) Gizi : ruangan panas → sudah diberi exhouse masih tetap suhu tinggi 2) Laundry : kepatuhan dari petugasnya yang kurang 3) Berlebihan penggunaan APD → efeknya boros → Karu berperan dengan melist	1. PMKP 2. PPI 3. Karu



			penggunaan yang berlebihan → data kepatuhan APD sudah ada di SIMRS 2. Identifikasi Pasien → share rekapnya di grup RAKOR KARU 3. Kepatuhan waktu visite dokter → diupayakan untuk diperbaiki 4. Kepatuhan CP → belum ada SK nya → dibuat SK	
		4. IKP	1. IKP tetap dilaporkan → untuk perbaikan pelayanan rumah sakit → semua laporan bisa dilaporkan melalui <i>Whatsapp</i> ke Direktur 2. IKP Mutu dan Keselamatan Pasien	1. PMKP 2. Karu
2.	Pemaparan hasil capaian Tribulan (Januari-Maret 2026)	1. Pengisian CP	1. Pengisian CP di Farmasi dan Gizi harus diisi juga → pengisian bisa diisi ke komputer unit	1. Gizi 2. IFRS
		2. Laporan mutu unit	1. Mutu unit deadline dikumpulkan Kamis / 23 April 2026 2. Tindakan CP koordinasi dengan Casemix Manajer dan Kabid Yanmed 3. Laporkan hasil mut uke dr. Diah, Sp. M	1. PMKP 2. Seluruh Unit



				4. Rapat bulanan Unit yang membahas mutu untuk mengundang PJ PMKP di Rapat	
		a. Kepatuhan Penggunaan APD: Capaian belum konsisten 100% (rata-rata 96,5%). Masih ditemukan petugas yang berlebihan memakai APD dan tidak memakai APD sesuai risikonya, seperti pada petugas CSSD Laundry dan Dapur.		1. Sebelumnya sudah dilakukan tindak lanjut berupa supervisi langsung, sidak kepatuhan APD, penambahan ventilasi mekanik di area dapur supaya tidak panas untuk meningkatkan motivasi pemakaian APD. 2. Edukasi dan refresh training terkait standar penggunaan APD sesuai indikasi, audit kepatuhan secara berkala, supervisi langsung di ruangan, monitoring penggunaan dan stok APD diperhatikan	Komite PPI & Kepala Ruangan
		b. Kepatuhan Identifikasi Pasien: Masih ditemukan ketidakpatuhan dalam mengidentifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas pasien (nama lengkap dan tanggal lahir/nomor rekam medis). Beberapa petugas hanya mengidentifikasi pasien menggunakan		1. Koordinasi dengan kepala ruang untuk menjalankan tugasnya sebagai validator data serta mengingatkan untuk tetap melakukan identifikasi pasien sesuai SPO untuk menghindari insiden keselamatan pasien.	1. Komite PMKP 2. Kepala Ruang



		nama saja, yang dapat berisiko terhadap keselamatan pasien		
		c. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway): Kurangnya pemahaman petugas mengenai penggunaan alur klinis, keterbatasan waktu dalam pengisian dokumen, serta kurangnya monitoring dari unit terkait. Kepatuhan pengisian CP masih sangat jauh dari standar.	1. Sudah dilakukan perbaikan untuk CP dan disesuaikan dengan diagnose terbanyak sesuai dari kemenkes. 2. Form CP yang diperbarui bisa diakses di web direksi pada menu komite PMKP. 3. Sosialisasi terkait pengisian dokumen alur klinis (clinical pathway). 4. Reminder pengisian dokume clinical pathway. 5. Menghimbau kains farmasi dan gizi terkait pengisian dokumen clinical pathway ketik staf visite.	1. Komite PMKP 2. Karu 3. Ahli Gizi 4. Apoteker
		d. Manajemen Risiko: Evaluasi program Manajemen Risiko RS. Petugas unit masih banyak yang belum memahami daftar risiko yang ada di unitnya masing-masing.	1. Kepala ruang wajib mengajarkan pada anggotanya untuk mengetahui risiko yang ada diunitnya karena unit itu sendiri yang harus melakukan pengendalian risiko.	1. Sub Manrisk Komite PMKP 2. Kepala ruang/instalasi



			2. Daftar Risiko unit bisa dilihat pada web direksi yang bisa diakses juga oleh seluruh staf.	
		e. Surveilans HAIs (IDO, IADP, VAP, ISK), Angka Plebitis: Capaian Angka HAI's 0% pada triwulan ini. Kejadian phlebitis masih ditemukan namun sudah berangsur turun kejadiannya.	1. Koordinasi dengan komite keperawatan terkait skill pelayanan keperawatan pasien. 2. Tetap melakukan monitoring di unit, koordinasi dengan karu unit.	1. Komite PPI 2. KOMite PMKP 3. Kepala ruang
		f. Program Komite	Program Komite perlu evaluasi untuk kendala dan progress → harus ada dokumennya	Komite
3.	Kejadian Kecelakaan Kerja Staf	Tidak terjadi kecelakaan kerja pada triwulan ini.	Sosialisasi K3, pelaporan insiden maksimal 2x24 jam	Komite K3RS & SDM
4.	Edukasi Individu (PKRS)	Dokumentasi nama & tanda tangan belum konsisten	Supervisi dan standarisasi format dokumentasi	Tim PKRS & Kepala Unit
5.	Kepuasan Pasien	Penurunan di Januari (99,70%) dibandingkan Februari-Maret 2026	Analisa komplain dan survei kepuasan mendalam	Tim PMKP & Humas
6.	Prognas	Standar Prognas di Akreditasi	Standar Prognas harus 100%	Prognas



7.	Pelayanan	Peningkatan pasien	Peningkatan pasien sudah dilakukan antisipasi dengan meminimalisir pending klaim oleh Kabid Yanmed dan Casemix Manajer	1. Kabid Yanmed 2. Casemix Manajer
----	-----------	--------------------	--	---------------------------------------

Pemimpin Rapat
Direktur RS Prima Husada Malang



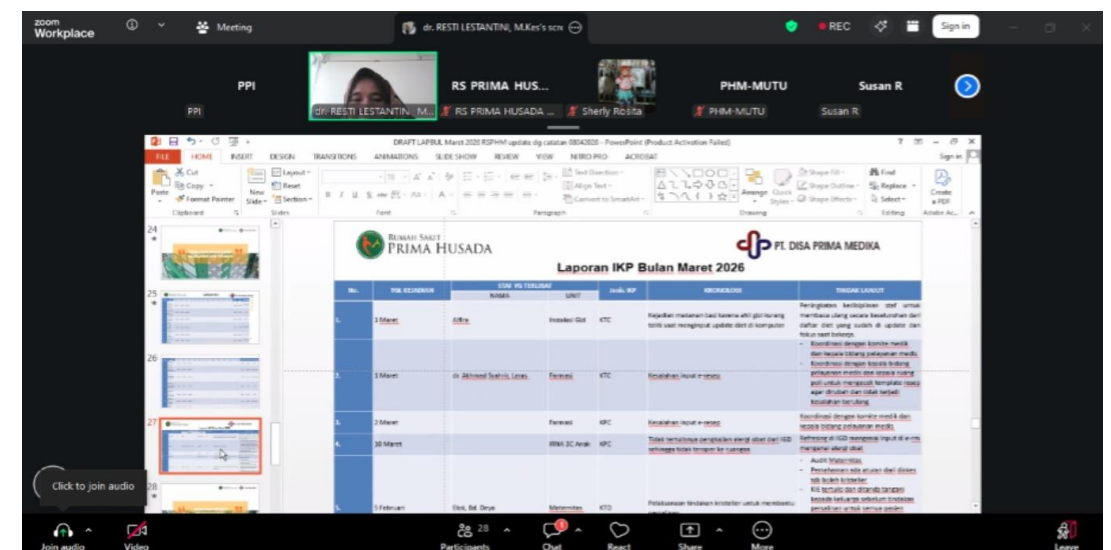
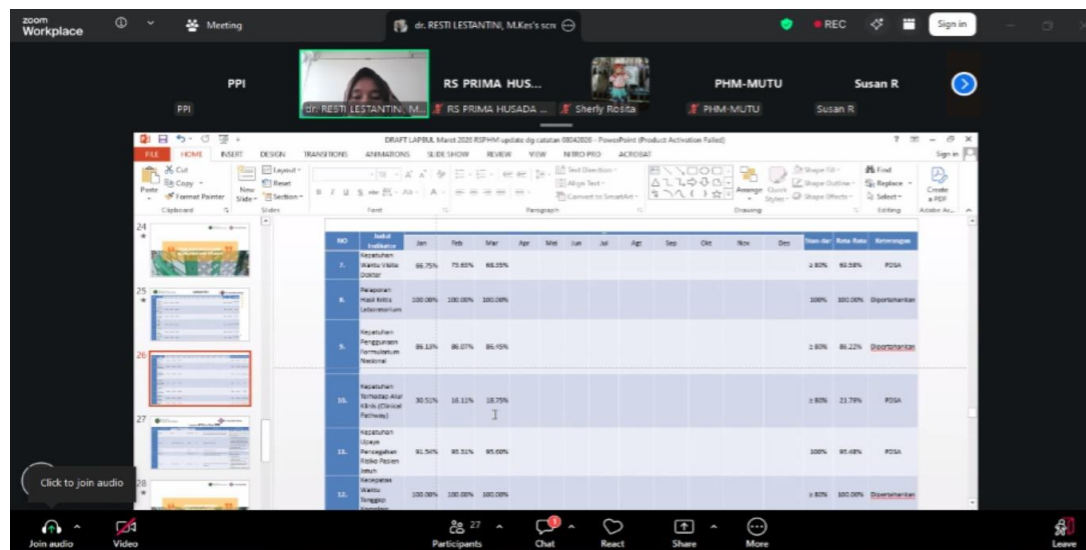
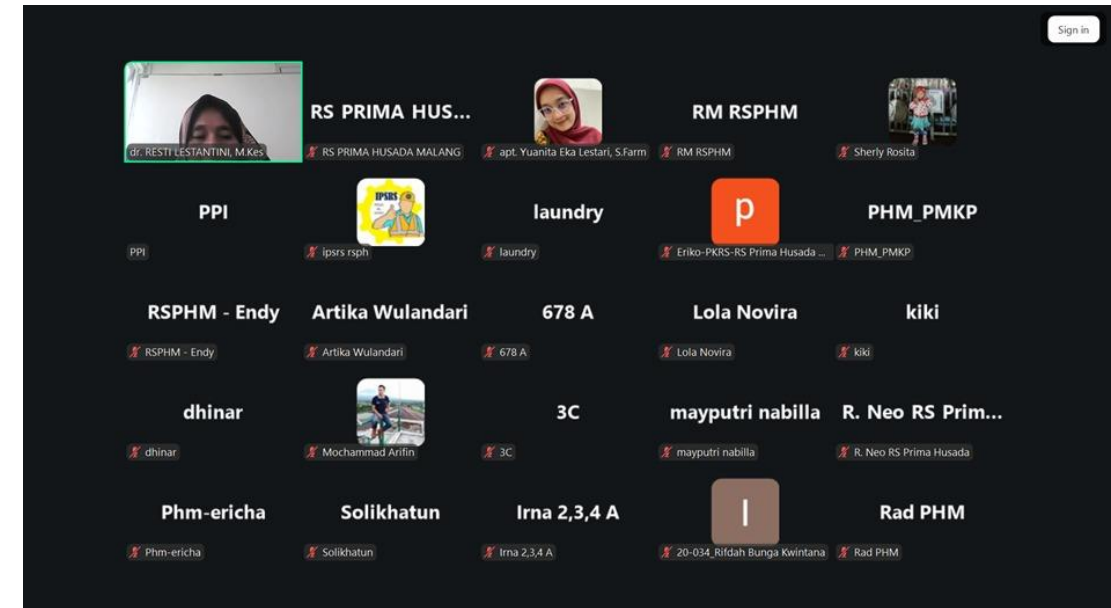
dr. Resti Lestantini, M. Kes

Malang, 22 April 2026
Notulis

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Mahesa Yudistiranti, S. AP

DOKUMENTASI



Banjararum Selatan No 3 – 7 Singosari – Malang,
Telp 0341 – 458679, 458916, Fax : 441874; Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com